

Nos basamos en el triage y en la ruta ideal o teórica, y la estructura de leyes o normal, contrastada con la experiencia del equipo en relación a sus vivencias en las urgencias. En un inicio partimos con la ruta teórica (**Punto 4**) en la cual se define los procesos que suceden durante la atención a urgencias. De la misma forma se desglosa y se analiza los pasos que se presentan en dicho punto 4. Además se tiene en cuenta casos extraordinarios o especiales que se pueden presentar (**Punto 7**) para la definición de los **RF**.

4. Vista general de la ruta

La ruta tiene un **carril clínico** y un **carril administrativo** que se ejecutan en paralelo. La regla estructural, verificada en la norma, es que **el triage va primero y la verificación de derechos va después, sin poder retrasar la atención inicial** [V].

#	Etapas	Responsable principal	Registro / salida	Base
0	Llegada y registro mínimo (por sus medios, ambulancia/APH, o remitido de otra IPS) — ver 5.0	Paciente, APH, IPS remitora, registro de llegada	Documento, fecha y hora de ingreso; documentación de remisión si aplica	Res. 5596 art. 10; Dec. 4747 art. 17 [V]
1	Triage	Profesional de triage	Identificación, fecha y hora de ingreso y de triage, categoría I a V	Res. 5596 arts. 5, 8, 9, 10 [V]
2	Admisión y verificación de derechos	Admisiones	ERP identificada, tipo de cobertura, inconsistencias	Dec. 4747 art. 11; Res. 5596 art. 6 parágrafo [V]
3	Atención inicial de urgencias	Médico de urgencias	Historia clínica, diagnóstico CIE-10, órdenes	Res. 373/2026 [V]; Res. 1995/1999 [C]
4	Observación y reevaluación	Médico y enfermería	Evolución; reevaluación periódica de quienes esperan	Res. 5596 art. 6.5 [V]

#	Etapas	Responsable principal	Registro / salida	Base
5	Conducta o destino	Médico tratante	Alta, hospitalización, remisión, UCI/cirugía o fallecimiento	Res. 373/2026 [V]
6	Componentes administrativos posteriores	Admisiones, gestión de remisiones, facturación, calidad	Informe de urgencias, autorizaciones, referencia, reporte, FEV y RIPS, glosas	Ver sección 6

5. Detalle de la ruta clínica

5.0 Etapa 0: Llegada y registro mínimo

Esta etapa cubre el momento en que el paciente llega al servicio y queda registrado, antes de cualquier trámite administrativo. Es donde arranca el reloj de los tiempos de espera.

Formas de llegada

- **Por sus propios medios**, solo o con acompañante.
- **En ambulancia o atención prehospitalaria (APH)**, desde el lugar del evento o por regulación del CRUE.
- **Remitido de otra IPS** (referencia): trae la documentación de la remisión. La IPS remitora responde por el paciente hasta que ingresa a la institución receptora (Dec. 4747, art. 17) [V].

Regla clave: todos pasan por triage, incluso el paciente consciente y estable

- **Ningún paciente se salta el triage** por llegar consciente o parecer estable. El triage es una valoración clínica breve que decide la prioridad; la hace el profesional de triage y no depende de la apariencia (Res. 5596, arts. 3 y 4) [V].
- Un paciente consciente puede quedar en categoría II (por ejemplo, por dolor extremo o riesgo de deterioro) y pasar a atención de inmediato; otro, en III, IV o V, esperará su turno [V].
- Un paciente en Triage I no espera ningún trámite: pasa directo a atención inmediata y su registro se completa después [V].
- El triage se realiza **a la llegada** y la verificación de derechos es **posterior**, sin poder retrasar la atención inicial (Res. 5596, art. 6 parágrafo; Dec. 4747, art. 11 parágrafo 1) [V].

Registro de llegada (mínimo obligatorio)

La norma exige registrar la información del triage de **todo paciente que ingrese** al servicio. El contenido mínimo es (Res. 5596, art. 10) [V]:

- Identificación del paciente.
- Fecha y hora de ingreso.
- Fecha y hora de realización del triage.
- Clasificación (categoría I a V).

La Res. 373 de 2026 reporta además la identificación única del usuario por tipo y número de documento más fecha y hora de ingreso, para evitar duplicados [V, vía prensa especializada]. Por eso el sistema debe capturar **desde la llegada** el tipo y número de documento y la hora exacta de ingreso.

Flujo del paciente consciente y estable (categorías III, IV o V)

Paso	Qué ocurre	Registro	Base
1	Llega y se toman los datos básicos de identificación.	Documento, fecha y hora de ingreso	Res. 5596 art. 10 [V]
2	Pasa al triage; el profesional lo entrevista, lo evalúa y lo clasifica.	Hora de triage, categoría, quién lo clasificó	Res. 5596 arts. 8-10 [V]
3	Se le informa la categoría, el área de tratamiento y el tiempo estimado de espera.	Constancia de información (recomendable)	Res. 5596 art. 9.6 [V]
4	Espera con reevaluación periódica; si empeora, se reclasifica.	Historial de categorías y horas	Res. 5596 art. 6.5 [V]
5	Durante la espera se hace la verificación de derechos y la admisión administrativa completa, sin frenar la atención.	ERP, cobertura, inconsistencias	Dec. 4747 art. 11 [V]
6	Es llamado a consulta médica.	Fecha y hora de consulta (cierra el tiempo de espera)	Res. 373/2026 [V]

Lo que la norma no define (validar con la IPS de referencia) [C]

- Quién toma el registro mínimo de llegada: admisiones o el mismo profesional de triage.
- Si se usa turno, ficha o número de fila, y cómo se organiza la sala de espera.
- Cómo se registra al paciente que no puede dar sus datos o llega sin documento.
- Qué pasa si el paciente se retira antes de ser clasificado o atendido.

Decisión de diseño sugerida: separar el **registro de llegada** (mínimo, inmediato, arranca el reloj) de la **admisión administrativa completa** (posterior, incluye verificación de derechos). Un paciente puede tener el primero sin el segundo, y el sistema no debe bloquear la atención por eso.

5.1 Etapa 1: Triage

Definición [V]: valoración clínica breve que determina la prioridad con la que se atenderá al paciente, según sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Es un proceso dinámico: cambia tan rápido como el estado clínico del paciente. **En ninguna circunstancia puede usarse para negar la atención** (Res. 5596, arts. 3 y 4).

¿Quién realiza el triage? (Res. 5596, art. 8) [V]

- **Urgencias de alta y mediana complejidad:** profesionales en **medicina o enfermería**.
- **Urgencias de baja complejidad:** puede ser realizado por **auxiliares de enfermería o tecnólogos en atención prehospitalaria**, con la supervisión médica correspondiente.
- Todo el personal de triage debe tener **constancia de asistencia a cursos o actividades de formación** en el sistema de triage que aplica la IPS.

Responsabilidades de quien hace el triage (art. 9) [V]

- Organizar y garantizar el orden en que se realiza el triage a quienes llegan.
- Entrevistar al paciente o acompañante y evaluarlo de manera oportuna y pertinente.
- Clasificarlo según la metodología de triage de la IPS y los criterios del Ministerio.
- Registrar los datos obtenidos.

- Informar al paciente o acompañante el resultado, el área de tratamiento y el tiempo estimado de espera.

Categorías (art. 5) [V]

Categoría	Criterio (resumen)	Tiempo definido por la norma
Triage I	Riesgo vital; requiere maniobras de reanimación por compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico, o pérdida de miembro u órgano.	Atención inmediata
Triage II	Puede evolucionar a deterioro rápido o muerte, o a pérdida de miembro u órgano. El dolor extremo se considera criterio de esta categoría.	No debe superar 30 minutos
Triage III	Requiere medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias; estable fisiológicamente pero puede empeorar si no se actúa.	Lo define cada IPS (tiempo promedio publicado)

Triage IV	No compromete el estado general ni la vida; hay riesgo de complicación o secuelas sin atención.	Lo define cada IPS
Triage V	Problema agudo o crónico sin deterioro del estado general ni riesgo evidente para la vida o la funcionalidad.	Lo define cada IPS

Corrección importante: la norma solo fija tiempos para las categorías I y II. Para III, IV y V, cada IPS debe **establecer tiempos promedio de atención, informarlos a pacientes y acompañantes y publicarlos en un lugar visible** del servicio (art. 6.4). Los tiempos no aplican en emergencias o desastres con múltiples víctimas (art. 5, parágrafo).

Otras obligaciones de la IPS en el triage (art. 6 y 10) [V]

- Implementar un método de **cinco categorías** que cumpla la resolución y garantizar los recursos físicos, humanos y técnicos.
- El triage se realiza **a la llegada** del paciente.
- **Reevaluación periódica** de los pacientes ya clasificados que esperan atención definitiva.
- Registro mínimo de **todo paciente** que ingrese: identificación, fecha y hora de ingreso, fecha y hora del triage y clasificación.

5.2 Etapa 3: Atención inicial de urgencias

Tras el triage, el paciente pasa al área de tratamiento asignada. El médico realiza la valoración, ordena ayudas diagnósticas y tratamiento, y registra el diagnóstico. Según el Anexo de la Res. 373 de 2026, el reporte de tiempos captura el momento de la consulta médica posterior al triage, el diagnóstico principal CIE-10, las interconsultas (solicitud y atención efectiva), las ayudas diagnósticas con fechas, horas y códigos CUPS, y la prescripción y administración de medicamentos con marca temporal [V, vía prensa especializada].

Si hay urgencia vital, la estabilización prima sobre cualquier trámite administrativo (Dec. 4747, art. 11, parágrafo 1) [V].

5.3 Etapas 4 y 5: Observación y conducta

El médico decide el destino del paciente. Las opciones que contempla el reporte de la Res. 373/2026 son: interconsulta, remisión a otra IPS, hospitalización o alta/egreso [V, vía prensa

especializada]. Además hay que prever el fallecimiento y el traslado a UCI o cirugía dentro de la misma institución.

- **Alta:** indicaciones al paciente; si necesita servicios posteriores, se activa el trámite de la sección 6.3.
- **Hospitalización en la misma IPS:** si pertenece a la red de la ERP y el servicio está contratado, la atención posterior debe continuar en la institución que hizo la atención inicial, salvo excepciones (mejor condición en otro prestador, sin disponibilidad o solicitud expresa del usuario) (Dec. 4747, art. 14, parágrafo 2) [V].
- **Remisión:** sección 6.4.

7. Flujos alternos y casos especiales

Situación	Tratamiento en la ruta	Base
Paciente sin documento o sin afiliación identificada	Se clasifica y atiende igual. La verificación de derechos es posterior y las inconsistencias se reportan sin afectar la atención.	Dec. 4747 art. 11 [V]
Emergencia o desastre con múltiples víctimas	Los tiempos de atención por categoría no aplican.	Res. 5596 art. 5 par. [V]
Paciente triage I	Pasa directo a atención inmediata; el registro administrativo es posterior.	Res. 5596 art. 5.1 [V]
Paciente en espera reclasificado	La reevaluación periódica puede cambiar su categoría; el sistema debe conservar el historial de categorías.	Res. 5596 arts. 3 y 6.5 [V]
ERP no responde la remisión en 2 horas	Se escala al CRUE.	Res. 2335 art. 11.1 [V, ABECÉ]
ERP no responde autorización posterior	El prestador atiende y factura con evidencia de la solicitud; no procede glosa por falta de autorización.	Dec. 4747 art. 14; ABECÉ [V]
Paciente que abandona el servicio antes de ser clasificado o atendido	La norma consultada no lo regula de forma expresa. Definir procedimiento institucional y registro.	A validar con la IPS de referencia
Menor de edad sin acompañante, o paciente sin capacidad de decidir	Se atiende; el consentimiento y el aviso a autoridades siguen reglas propias.	[C]
Accidente de tránsito	Cobertura SOAT/ADRES; requiere soportes propios de reclamación.	[C]
Fallecimiento en urgencias	Certificado de defunción, notificación y traslado según procedimiento institucional.	[C]